EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 91654
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-29 14:06:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NORA ROSARIO SAAVEDRA MORALES			RUN	: 9.502.985-K
F.Nac	: 14-09-1957	Edad	: 66 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: GRAL PARRA PJE. CAROL URZUA 444 act			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 9-56639677		
Fecha Ingreso	: 2024-08-28	Fecha Egreso	: 2024-08-29 14:06:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. B69.0-CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Neurocisticersosis subaracnoidea
-Aracnoiditis crónica cisternas basales
-Ataxia sensitiva
-Obs mielopatía en estudio, obs 2° NCC subaracnoidea medular
-Cefalea tipo migrañosa en estudio, obs 2° a procedimiento quirúrgico (instalación DVE)
-Obs RAM VPA (temblor postural y reposo)
-Epilepsia 2°
-Portadora DVE derecho
-Ant: HTA - Hipotiroidismo - TBQ

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. B69.0-CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente BEG, HDN estable, RS al monitor, eupneica, afebril, tolera bien alimentación VO, refiere dificultad para la marcha (usa andador), temblor EE y cefalea hemicranea izquierda tipo migrañosa (asociada a nauseas, sonofobia, fotofobia, aumenta con act física, sin aura, dura>4h) iniciado posterior a instalación DVE en abril/24.
RM cerebro muestra NCC subaracnoidea de cisternas basales y peritroncales y aracnoiditis perimesencefálica, sin hidrocefalia, punta de cateter DVP en cuerpo VL izq.
TC cerebro del 28/8/24 sin hidrocefalia, punta cateter DVP en cuerpo VL izq.
NQx HHM descartó disfunción de DVP.
Diuresis(+) dep(-)
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio para continuar rehabilitación kinésica por HODOM, suspendo VPA y sertralina y aumento LVT, inicio tratamiento sintomático de cefalea y espasticidad, solicito exs de lab generales (incluyendo B12, RPR, VIH, folato y pruebas tiroideas), panel reumatológico, ac anti HTLV I y II, RM columna total c/c, exs de control en 2 semanas (hemograma y hoja hepática), continuar tratamiento antihelmíntico (asociado a prednisona 40 mg/d) con albendazol 1200 mg/d por al menos 3-6 meses, RM cerebro y médula c/c de control c/3 meses, y control en policlínico de Neurología en 2-3 semanas.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy para continuar rehabilitación kinésica por HODOM,
-Exs de lab hoy previo a alta
-Hemograma y hoja hpática en 2 semanas
-RM columna total c/c
-Continuar tratamiento antihelmíntico con albendazol 1200 mg/d por al menos 3-6 meses (asociado a

prednisona 40 mg/d)
-RM cerebro y médula c/c de control c/3 meses
-Control en policlínico de Neurología en 2-3 semanas
-Suspender tabaquismo
-Reinicio de tratamiento antihipertensivo ambulatoriamente por equipo HODOM, según controles de PA

INDICACIONES AL ALTA

1. -Levetiracetam 500 mg 2 comp c/12 horas
2. -Levotiroxina 50 ug/día 30 min antes del desayuno
3. -Paracetamol 500 mg 2 comp c/8h SOS si cefalea
4. -Propranolol 40 mg 1/2 comp c/12 horas
5. -Prednisona 20 mg 1 comp al desayuno y 1 comp al almuerzo
6. -Albendazol 400 mg 2 comp al almuerzo y 1 comp a la cena
7. -Cotrimoxazol 800/160 mg 1 comp lunes-miercoles-viernes
8. -Calcio+vit D 1/día
9. -Omeprazol 20 mg/día
10. -Baclofeno 10 mg 1/2 comp c/12 horas
11. -Clonazepam 0.5 mg 1 comp/noche SOS en caso de insomnio o ansiedad

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-), balón DVP retroauricular derecho de consistencia renitente (mpresiona N), trayecto subcutaneo DVP impresiona sin signos de infección
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos +/+

Ex neurológico:
-Mental: conservado
-PC: CV por amenaza impresiona N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, discreta PFC izq en reposo, disartria(-), nistagmo(-), pares bajos N
-Motor: PPP(-), tetrapiramidalismo (c/espasticidad) simétrico, temblor postural y acción EESS, temblor/mioclonías posturales EEII, RCP flexor bilateral
-Sensibilidad: hipopalestesia 4 EE largo-dependiente, sensibilidad táctil impresiona N, nivel sensitivo cervical bajo y dorsal medio
-Cerebelo: impresiona conservado
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO